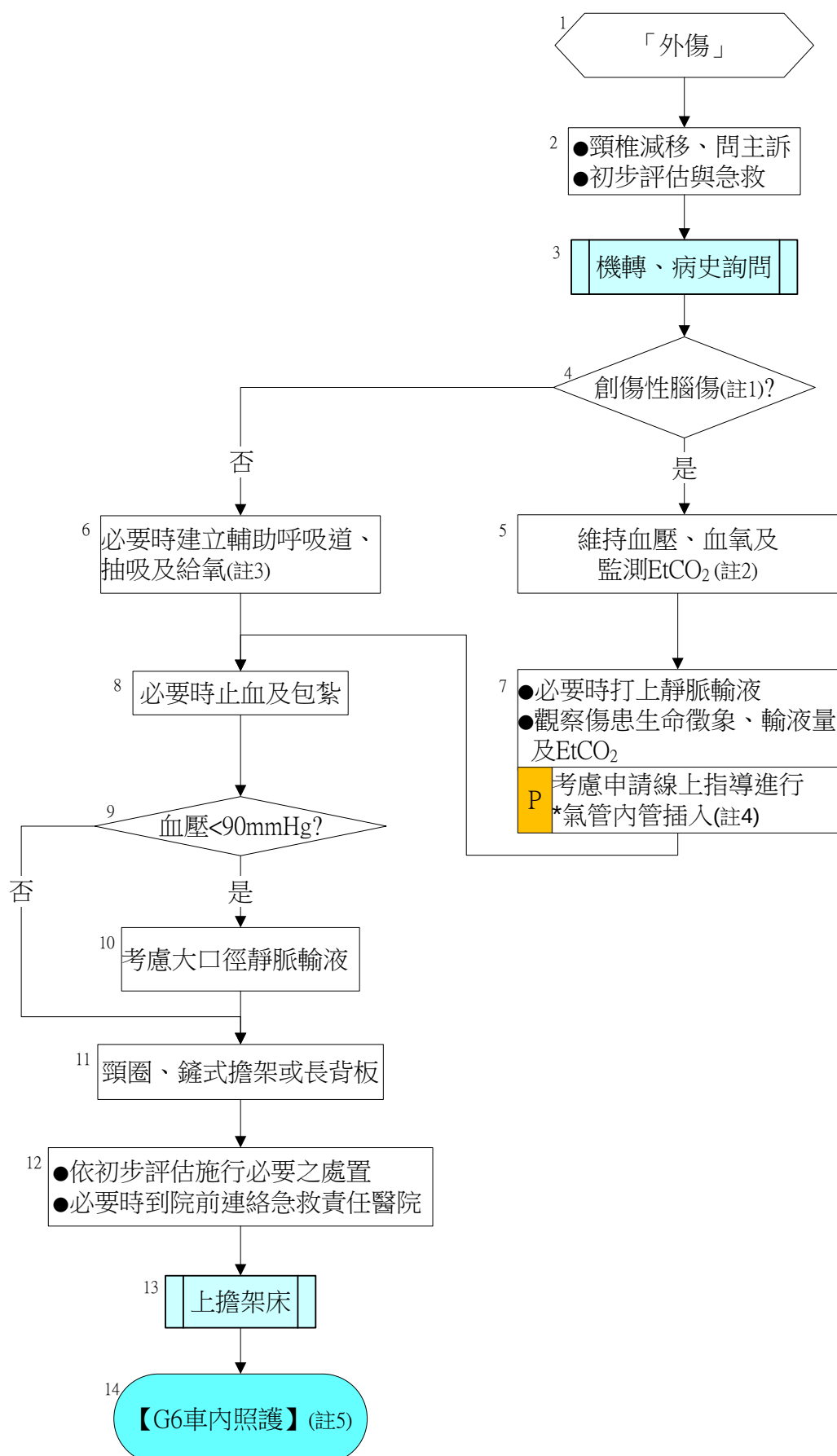


T2 外傷性腦傷

程 序



要 旨

- 一、外傷性腦部的損傷可分為原發性 (primary;外力直接造成的腦損傷) 及續發性 (secondary;腦灌流不足所造成的腦受損傷)。後者往往比前者造成更多的死亡，所以在外傷性腦部的損傷的傷患維持足夠的腦部灌流 (亦即避免低血壓及低血氧)，是EMT非常重要的任務。若頭部外傷傷患狀況惡化，可能變得躁動不安或更為昏沉。這可能是腦部灌流不足的徵象。大腦缺氧是頭部外傷最常見之死因。此時應重新評估呼吸道、換氣狀況及評估血壓等 (ABC)，並予以必要的處置。
- 二、單純頭部外傷並不會導致低血容性休克 (但在「兒童」或「併發頭皮嚴重撕裂傷出血」則有可能)。單純頭部外傷的傷患若呈現心搏過速和低血壓狀況，需重新評估是否伴隨其他外傷導致低血容性休克。
- 三、EMT能提供急診醫師的重要資訊包括一傷患生命徵象是否穩定、意識狀況改變、轉送過程是否惡化、抑或改善。
- 四、對於所有頭頸部鈍傷傷患均假設其合併有頸椎外傷。

註 解

註1>

- 一、頭部外傷並符合下列任一情形，傷患即為疑似外傷性腦傷：
 - (一) GCS<12(或對聲音沒有反應)、GCS<15且持續變差(如一次掉2分以上)。
 - (二) 外傷後抽搐。
 - (三) **P** 多重外傷且需插管之傷患。
- 二、有關外傷性腦傷所需的特殊訊息
 - (一) 受傷機轉、撞擊力量、是否戴安全帽。
 - (二) 是否喪失意識 (時間長短)、意識改變的程度、外傷前後記憶喪失、活動狀況。
 - (三) 過去病史—藥物使用狀況、過去是否存在其他疾病、癲癇病史。
- 三、有關外傷性腦傷所需觀察的特殊事項
 - (一) 生命徵象。
 - (二) 神經學評估—瞳孔大小及光反應、昏迷指數。
 - (三) 外傷—鈍挫傷、擦傷、撕裂傷、耳鼻出血。

註2>

- 一、疑似外傷性腦傷傷患維持血氧 $\geq 94\%$ 、維持血壓 $\geq 110\text{mmHg}$ 、必要時BVM通氣每6秒給1口氣、 EtCO_2 可監測時維持 $\geq 35\text{-}45\text{mmHg}$ 。
- 二、若現場無適當之 EtCO_2 機器可偵測，且傷患血氧 $< 90\%$ ，以BVM通氣每6秒給1口氣。

註3>

- 一、評估呼吸道是否通暢及呼吸狀況。
- 二、給予氧氣鼻管或面罩，使用脈衝式血氧飽和濃度（ SpO_2 ）維持 $\geq 94\%$ 以上。

註4> **P**

GCS=3且無法以口咽呼吸道(或SGA)及BVM維持 $\geq 85\%$ 時，經線上醫療指導同意始得為之。（依【[A1](#)成人氣管內管插管】）

註5>

- 一、對耳鼻道出血不需嘗試止血，僅需用乾淨紗布覆蓋防止污染即可。
- 二、對於多處外傷、生命徵象不穩定或中度頭部外傷以上的傷患要儘速轉送本市重度級醫院或區域配合之創傷醫院。